



OSVIMEC 300

CÔNG THỨC:

Cefdinir 300mg
Tá dược (natri laurylsulfat, magnesi stearat, avicel, aerosil) v.đ. 1 viên
TRÌNH BÀY: Hộp 1 vỉ - Vỉ 10 viên nang cứng.

CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỢI HỢC:

- Cefdinir là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng, thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3. Cũng như các cephalosporin khác, cefdinir tác dụng bằng cách ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn.
 - Cefdinir bền vững với một số men beta-lactamase. Vì vậy, nhiều chủng kháng penicillin và một vài cephalosporin vẫn còn nhạy cảm với cefdinir.
 - Cefdinir tác dụng hầu hết trên các chủng vi khuẩn cả in vitro và trên lâm sàng như:
 - Vi khuẩn Gram dương hiếu khí, gồm: *Staphylococcus aureus* (kể cả chủng sinh beta-lactamase), *Streptococcus pneumoniae* (chúng nhạy cảm với penicillin), *Streptococcus pyogenes*.
 - Vi khuẩn Gram âm hiếu khí, gồm: *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, và *Moraxella catarrhalis* (kể cả các chủng sinh beta-lactamase).
 - Cefdinir không có tác dụng trên *Pseudomonas*, *Enterobacter species*, *Staphylococci* kháng methicillin và các vi khuẩn yếm khí.
- ## CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Cefdinir được hấp thu qua đường tiêu hóa, sau khi uống nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 2 - 4 giờ. Sinh khả dụng đường uống vào khoảng 16 - 25%.
 - Cefdinir phân bố rộng khắp các mô trong cơ thể. Khoảng 60 - 70% liều uống gắn kết với protein huyết tương, sự gắn kết này không phụ thuộc vào nồng độ.
 - Cefdinir chuyển hóa không đáng kể và thải trừ trong nước tiểu với thời gian bán thải khoảng 1,7 giờ. Độ thanh thải của cefdinir giảm ở người suy giảm chức năng thận.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Người lớn và thiếu niên:

- Viêm phổi mắc phải cộng đồng, do các tác nhân *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus arainfluenzae*, *Streptococcus pneumoniae* (chúng nhạy cảm với penicillin), và *Moraxella catarrhalis* (gồm cả chủng sinh beta-lactamase).
- Đợt cấp của viêm phế quản mãn, cũng do bởi những tác nhân kể trên.
- Viêm xoang cấp tính do *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* (gồm cả chủng sinh beta-lactamase).
- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da do *Staphylococcus aureus* (gồm cả chủng sinh beta-lactamase) và *Streptococcus pyogenes*.

Trẻ em:

- Viêm tai giữa cấp gây ra bởi *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, và *Moraxella catarrhalis* (gồm cả chủng sinh beta-lactamase).
- Viêm hầu họng/viêm amidan do *Streptococcus pyogenes*.
- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da do *Staphylococcus aureus* (gồm cả chủng sinh beta-lactamase) và *Streptococcus pyogenes*.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với kháng sinh họ cephalosporin, penicillin.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử viêm đại tràng.

*** Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Chỉ dùng khi thật cần thiết.

*** Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:**

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ban đỏ, đau đầu. Rất hiếm khi bị hội chứng Stevens-Johnson, ban đỏ đa dạng, viêm đại tràng giả mạc, vàng da, giảm huyết cầu, giảm bạch cầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Furosemid dùng đường uống làm tăng độc tính của cefdinir dùng đường uống bởi tác dụng của thuốc thêm vào, làm gia tăng độc tính với thận nếu dùng chung.
- Tránh sử dụng đồng thời với các thuốc gây độc cho thận như aminoglycosid, colistin, polymyxin B, vancomycin vì nguy cơ làm tăng độc tính với thận.
- Probenecid làm giảm sự bài tiết qua thận của Cefdinir và làm tăng nồng độ trong trong huyết thanh và thời gian bán thải của cefdinir.
- Hồi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đồng thời chloramphenicol và cefdinir, kết hợp này có thể làm giảm tác dụng của cefdinir trong việc điều trị một số nhiễm khuẩn.
- Các thuốc antacid và các chế phẩm có chứa sắt làm ảnh hưởng tới việc hấp thu cefdinir. Cần phải uống trước hoặc sau cefdinir khoảng 2 giờ.
- Thuốc bổ trẻ em có bổ sung sắt ảnh hưởng không đáng kể đến sự hấp thu của cefdinir, nên có thể dùng đồng thời được. Phần cefdinir không hấp thu có thể tương tác với sắt cho phân có màu đỏ gạch.
- Phản ứng dương tính giả khi thử ceton niệu nếu dùng nitroprusside.
- Có thể cho kết quả dương tính giả khi thử glucose niệu bằng dung dịch thuốc thử Benedict hoặc Fehling.

- Các cephalosporin đôi khi cũng gây dương tính giả cho test Coomb trực tiếp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và thiếu niên (từ 13 tuổi trở lên):

- Viêm phổi mắc phải cộng đồng/viêm da và cấu trúc da: 300 mg/1 lần x 2 lần/ngày, trong 10 ngày.
- Đợt cấp của viêm phế quản mãn/viêm xoang cấp tính/viêm hầu họng/viêm amidan: 600 mg/1 lần/ngày, trong 5 - 10 ngày.

Trẻ em từ 06 tháng đến 12 tuổi:

- Viêm tai giữa cấp/viêm hầu họng/viêm amidan: 14 mg/kg/1 lần/ngày, trong 5 - 10 ngày.
- Viêm da và cấu trúc da: 7 mg/kg/1 lần x 2 lần/ngày, trong 10 ngày.

Bệnh nhân suy thận:

- Người lớn (độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút): 300 mg/lần/ngày.
- Trẻ em (độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút/1,73 m²): 7 mg/kg/ngày (tối đa 300 mg/ngày).

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo:

- Người lớn: 300 mg/ngày
- Trẻ em: 7mg/kg, tại thời điểm kết thúc một đợt chạy thận, cách ngày dùng một liều.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

- Chưa có thông tin về tình trạng quá liều cefdinir. Các triệu chứng và dấu hiệu ngộ độc quá liều các kháng sinh beta-lactam: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, co giật.
- Điều trị quá liều: Lọc máu.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ. BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

27 Nguyễn Chí Thanh - P.9 - Tp. Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam

ĐT: (0294) 3753121, Fax: (0294) 3740239